

慢性咳嗽病因评估与诊疗建议（扩展测试版）

慢性咳嗽病因评估与诊疗建议（扩展测试版）

文档定位

本文档用于 RAG 知识库检索、切片和重排测试，所属类别为“疾病症状与诊疗”，主题为“慢性咳嗽”。文档内容采用多层次标题、连续段落、项目符号、病例讨论与流程建议的混合结构，方便测试语义检索与推理。以下内容为教学与系统测试用途，不替代真实临床决策。

第1章 慢性咳嗽管理专题-1

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第1阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第1阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第1阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第2章 慢性咳嗽管理专题-2

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第2阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第2阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第2阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第3章 慢性咳嗽管理专题-3

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第3阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第3阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第3阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第4章 慢性咳嗽管理专题-4

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第4阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。

对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第4阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第4阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第5章 慢性咳嗽管理专题-5

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第5阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第5阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第5阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。

- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第6章 慢性咳嗽管理专题-6

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第6阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第6阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第6阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第7章 慢性咳嗽管理专题-7

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第7阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第7阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后第7阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第8章 慢性咳嗽管理专题-8

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第8阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第8阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后第8阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第9章 慢性咳嗽管理专题-9

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第9阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第9阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第9阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第10章 慢性咳嗽管理专题-10

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第10阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第10阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第10阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第11章 慢性咳嗽管理专题-11

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第11阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。

对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第11阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第11阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第12章 慢性咳嗽管理专题-12

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第12阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第12阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第12阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。

- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第13章 慢性咳嗽管理专题-13

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第13阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第13阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第13阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第14章 慢性咳嗽管理专题-14

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第14阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第14阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后第14阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第15章 慢性咳嗽管理专题-15

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第15阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第15阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后第15阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第16章 慢性咳嗽管理专题-16

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第16阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第16阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第16阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第17章 慢性咳嗽管理专题-17

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第17阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第17阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第17阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议2~4周进行一次短周期评估，3个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

第18章 慢性咳嗽管理专题-18

1) 场景描述

在门诊与病房协同管理场景中，第18阶段重点关注患者症状演变、基础疾病、危险因素与近期治疗反应。

对于疑似高风险人群，应尽早进行标准化评估并形成结构化病历，避免因信息缺失导致诊疗延误。

2) 评估要点

- 采集主诉、现病史、既往史、药物史与过敏史，明确是否存在红旗征象。
- 完成体格检查与必要辅助检查，并记录时间点以支持纵向趋势分析。
- 结合年龄、合并症、器官功能和依从性，对慢性咳嗽相关风险进行分层。

3) 诊疗建议

建议采用“先稳定、再明确病因、后个体化干预”的分步策略。第18阶段应优先完成症状控制与风险排查，同时建立复评节点，确保治疗方案可被连续追踪。对治疗反应不佳或快速恶化者，应及时升级处置或转诊。

4) 病例讨论

某患者在初诊时以“慢性咳嗽相关不适”就诊，伴随睡眠受扰、活动耐量下降及焦虑情绪。经系统评估后，第18阶段采取联合干预策略，包括生活方式管理、分级药物调整、阶段性复查和健康教育。随访结果显示其核心症状逐步缓解，关键指标趋于稳定，但在长期管理中仍需持续监测并强化依从性。

5) 质控与随访

- 建议 2~4 周进行一次短周期评估，3 个月进行阶段复盘。
- 对异常指标应记录触发阈值、干预动作与反馈结果，形成闭环管理。
- 加强患者宣教，明确复诊时点、预警症状和居家监测方法。

附录 A：慢性咳嗽检索标签建议

- 一级标签：疾病分类、症状分层、治疗阶段、随访节点。
- 二级标签：高危因素、用药策略、禁忌证、复查项目、转诊指征。
- 结构标签：定义段、流程段、案例段、问答段、注意事项段。

附录 B：RAG 测试建议

1. 进行段落级切片（300~500 字）与章节级切片（1000~1500 字）对比测试。
2. 测试召回指标：Top-K 命中率、MRR、答案覆盖率与幻觉率。
3. 测试生成指标：答案完整性、证据可追溯性、术语一致性与时序一致性。
4. 引入多轮问答与跨章节引用，验证长上下文拼接稳定性。